جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : علا على حسنى على

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مصر القديمه **العنوان :** ++++++++++++++++++....

رقم البطاقة : 27801160104061 **رقم التليفون :** 01157070170 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 16-01-1978 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------) **التوقيع:(----------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي الصدر بالصبغه [10851] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: علا على حسنى على
National ID: 27801160104061

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced chest CT

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

علا
على حسنى على رضوان
٣٠ ش وردان الرومى - أبوالسعود
مصر القديمة - القاهره

١٩٧٨/٠٧/١٦

٢٧٨ ٠١ ١٦ ٠١ ٠٤٠ ٦١

KU0404934



٢٧٨٠١١٦٠١٠٤٠٦١ ٢٠٢٤/١٠
محامية حرة

أنثى مسلمة متزوجة
محمد ابراهيم عبدالمقصود ابراهيم
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٠/٠٤



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

صحة هى مصر

MDT FORM 13/11/2023 G

MDT

		MRN	٠٠٤١٥٨٠
		ID	٢٧٨٠١١٦٠١٠٤٠٦١
		Phone	٠١١٥٧٠٧٠١٧٠
enopausal status		Marital status	٠١٠٥٢٩١١٤١
RS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	ReMDT
CO morbidity			onc. C.C.

Clinical Data

BX: IDC, GrII

ER: 8/8 PR: 8/8 HER 2: 3+ Ki67: 30%

R L

TNM

2.2e lt breast Carc, relieved.
neoadj Rx → CT MEM + PC → a finished adj Hx
+ PORT
+ Cont. on Tam. Kiften/Zoladex fr 9/23
till Pregn →

PLAN & OUTCOME & PLAN part CT x 6 (Poor Compliance); plan for
DEXA SC → ASpirin osteoperid.
Re Zoneta 1 month

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: علا علي حسني	
MR. : 3999	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a premenopausal individual with left-sided breast cancer, staged clinically as T3 N1 M0. Tumor receptors are estrogen-receptor (ER) and progesterone-receptor (PR) positive. The patient received neoadjuvant chemotherapy consisting of anthracycline-cyclophosphamide (AC) plus a taxane (T) and HER2-targeted therapy (HP). Following neoadjuvant therapy, a left modified radical mastectomy (MRM) was performed with pathology showing no residual tumor in the breast (YPT0) and no nodal involvement (YPN0, 0/14 nodes). The patient is currently on tamoxifen (TAM) and a gonadotropin-releasing hormone agonist (Zoladex), both administered today, with the next Zoladex injection scheduled for 8/7.

The patient continues on tamoxifen, which has been administered for three months, and Zoladex, for which a new assessment has been requested.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر		

يعتمد ,

الطبية المتخصصة
ار السلام

بى

Pathology Report

Name: علا علي حسني Age: 42years

Clinical data : Left breast UOQ lesion.

Specimen type: Tur-cut biopsy.

Date (received): 29/11/2020 Date (reported): 7 /12/2020

Lab. Number: 1958 Hospital Number: مبادرة / 2020

Gross Description:

Five greyish white cores, biopsy the longest one measure 2x0.5cm the shor one measured 1x0.5cm, totally submitted.

Microscopic Examination

Section examined revealed breast tissue cores infiltrated by invasive maligna tumor formed of cords of moderately anaplastic ductal epithelial cells surrounded by desmoplastic stroma with focal insitu ductal component.

Diagnosis:

Left breast UOQ lesion, Tur-cut biopsy.

Invasive duct carcinoma grade II.

Focal insitu ducal component.

Prof. Dr. Gamal Abd El Ate

Dr. Enas Mohammed Ali

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Ola Ali Hosny Ali Rashwan	Date: 20/12/2023
Exam: C.T CHEST	Age: 45 Year(s)
Medical ID: 5820/2020	Pat. ID: 12049

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:

- Left mastectomy, applied breast expander . No surrounding soft tsiuse masses or enlaregd left axillary lymph nodes.
- Lingualr lobe fine reticulations likley post radiotehrapy changes.
- Clear rest of both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The examiend skeleton shwoing no worissome lytic or scelrotic leisons. No veretbral structural collapse.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Ola Ali Hosny Ali Rashwan	Date : 20/12/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 5820/2020	Pat. ID: 12049

Opinion:

- **No CT evidence of pulmonary, hepatic or osseus deposits on noncontrast basis.**

Dr.Shaimaa Megahed,MSc

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy

25/12/2023 03:23 م

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient name: Ola Ali Husainy

Date: 28-12-2022

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY AND BILATERAL HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

- Patient had left MRM .

Technique

- Right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

Left MRM side:

- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- Normal sonographic appearance of the tissue expander.
- No regional lymphadenopathy

Right breast:

- scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings.
- (BIRADS 2)

Yours truly

Dr.Peter Fahmy

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]